



ЗАВИСИМОСТИ И ТЯЖЁЛОЙ ОТМЁНЫ

14.05.2026 / **Новости**



ФЕНИБУТ: «НООТРОП» С РИСКОМ ИНТОКСИКАЦИИ, ЗАВИСИМОСТИ И ТЯЖЁЛОЙ ОТМЁНЫ

Автор: Жоров Е. Н.



Главный вывод авторов состоит в том, что клиническая и токсикологическая проблема фенибута недооценена. Его часто принимают вместе с другими психоактивными веществами, он плохо отслеживается стандартными токсикологическими скринингами, а врачи могут не распознавать интоксикацию или отмену, если специально не спрашивают пациента о «добавках», онлайн-препаратах и ноотропах. Поэтому авторы предлагают включить фенибут в токсикологический скрининг и разработать общепринятые стратегии ведения фенибут-ассоциированной токсичности.

Фенибут занимает странное положение между лекарством, «ноотропом», седативным средством и веществом с потенциалом злоупотребления. Фармакологически он связан с ГАМКергической системой: в обзоре подчёркивается активность фенибута в отношении GABA-B, GABA-A и β -фенэтиламиновых рецепторов. Именно это сочетание объясняет, почему пользователи могут ожидать от него анксиолитического, седативного или «когнитивно улучшающего» эффекта. Но та же фармакологическая логика делает понятными риски толерантности, зависимости, синдрома отмены и опасного взаимодействия с другими депрессантами центральной нервной системы.

Проблема стала особенно заметной после распространения фенибута за пределами стран, где он исторически использовался как лекарственное средство. В США и Европе он часто продаётся через интернет как продукт для сна, тревоги, стресса или когнитивной продуктивности. В американском регуляторном поле FDA прямо указывает, что фенибут не соответствует определению диетического ингредиента, а продукты, маркированные как dietary supplements и содержащие фенибут в качестве диетического ингредиента, считаются неправильно маркированными.

В клинической практике фенибут опасен прежде всего своей «маскировкой». Пациент может не воспринимать его как препарат и не сообщать врачу о приёме, особенно если покупал его как добавку или ноотроп. При этом интоксикация может проявляться неспецифично: седацией, нарушением сознания, возбуждением, делирием, психотическими симптомами, судорогами или вегетативной нестабильностью. Синдром отмены тоже может быть клинически неоднородным и напоминать отмену других седативных средств или алкоголя. Обзор подчёркивает, что помощь таким пациентам часто осложняется недостатком знаний о токсикологии и фармакологии фенибута.



делирии, тяжёлой бессоннице, тревоге, признаках отмены, изменении сознания или отрицательных результатах стандартного токсикологического скрининга на фоне убедительной клиники интоксикации.

Почему это важно

Фенибут – хороший пример того, как психофармакологически активное вещество может уйти из медицинского контекста в рынок «добавок» и вернуться к врачу уже в виде интоксикации, зависимости или синдрома отмены. Для психиатра, нарколога, токсиколога и врача приёмного отделения это потенциальный скрытый фактор в анамнезе. Особенно важно, что пациент может описывать его как «БАД», «ноотроп», «средство для сна» или «что-то от тревоги», а не как препарат с риском зависимости.

Что это меняет

Главный практический вывод обзора – фенибут нужно активнее искать в анамнезе. Вопрос о лекарствах уже недостаточен: нужно отдельно спрашивать о добавках, онлайн-средствах для сна, ноотропах, препаратах для тревоги, продуктах из спортивных и «биохакингowych» магазинов. Вторая задача – развитие лабораторного скрининга и клинических протоколов. Пока фенибут плохо виден в стандартной диагностике, его токсичность будет оставаться проблемой, которую распознают поздно и лечат эмпирически.

История фенибута показывает, что граница между лекарством, добавкой и веществом злоупотребления может быть очень подвижной. Если соединение действует на ГАМКергическую систему, вызывает седативный или анксиолитический эффект и свободно продаётся онлайн, оно неизбежно попадает в зону клинического риска. Поэтому разговор о «ноотропах» должен быть не маркетинговым, а фармакологическим: что это за мишень, какие эффекты ожидаются, как формируется зависимость, чем опасна отмена и почему отсутствие рецепта не означает отсутствие медицинского риска.



« Previous Post: 50 статей, которые сформировали психиатрию XXI века

Next Post: Доза имеет значение: антипсихотики и пролактин »

О ПИН